Клинические рекомендации

Паратонзиллярный абсцесс

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J36** — Перитонзиллярный абсцесс **J39.0** — Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс **J39.1** — Другой абсцесс глотки
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/664_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология 2

2.3 Локализация 2

2.4 Клиническая картина 3

2.5 Жалобы и анамнез 3

3. Диагностика 4

3.1 Осмотр и фарингоскопия 4

3.2 Ларингоскопия 4

3.3 КТ и УЗИ шеи 5

3.4 Анализы крови и мочи, посев 5

3.5 Дифференциальная диагностика 5

4. Лечение 6

4.1 Хирургическое лечение 6

4.2 Антибактериальная терапия 7

4.3 Дополнительная терапия 7

4.4 Послеоперационное ведение 8

5. Профилактика. Показания к госпитализации. Осложнения 8

6. Источник и актуальность 8

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Лечение в стационаре у оториноларинголога; основной метод: хирургическое вскрытие абсцесса.
- Диагноз подтверждают фарингоскопические признаки:
  1. гиперемия, отёк и инфильтрация нёбных дужек, миндалин, мягкого нёба и язычка;
  2. асимметрия мягкого нёба и смещение миндалины;
  3. ограничение открывания рта (тризм).
- Антибиотики широкого спектра, активные в отношении анаэробов, эмпирически, до результатов посева; курс **10–14 дней**.
- Абсцесстонзиллэктомия (миндалины удаляют одновременно со вскрытием):
  1. частые ангины в анамнезе;
  2. повторный паратонзиллит или абсцесс;
  3. затяжное течение;
  4. неадекватное дренирование;
  5. кровотечение после вскрытия;
  6. прочие тонзиллогенные осложнения.
- Если выполнено только вскрытие: двусторонняя тонзиллэктомия в плановом порядке **через 3 месяца**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Паратонзиллярный абсцесс характеризуется гнойным расплавлением паратонзиллярной клетчатки, расположенной между псевдокапсулой нёбной миндалины и глоточной фасцией, покрывающей констрикторы глотки.

2.2 Этиология

Пути инфицирования

1. осложнение ангины (большинство случаев);
2. хронический тонзиллит;
3. одонтогенный: кариес задних зубов нижней челюсти (вторые моляры, зубы мудрости), периостит альвеолярного отростка;
4. инородное тело в паратонзиллярной клетчатке (например, рыбная кость).

Наиболее частыми возбудителями являются бета-гемолитический стрептококк группы А и неспорообразующие анаэробные микроорганизмы.

На момент обращения отёчная форма паратонзиллита встречается редко, инфильтративная форма выявляется у 15–20% пациентов, абсцедирующая форма у 80–85%. Абсцесс формируется, как правило, через 4–6 дней от начала заболевания, в ряде случаев в течение нескольких часов.

2.3 Локализация

1. передневерхний (супратонзиллярный): более 70%; между капсулой миндалины и верхней частью передней нёбной дужки;
2. задний: около 15%; между миндалиной и задней нёбной дужкой;
3. нижний: несколько более 5%; между нижним полюсом миндалины и боковой стенкой глотки;
4. боковой: менее 5%; между средней частью миндалины и боковой стенкой глотки.

2.4 Клиническая картина

Абсцесс развивается, как правило, на фоне ангины или через несколько дней после неё.

1. боль при глотании, становится постоянной, резко усиливается при глотании слюны, иррадиирует в ухо и зубы;
2. головная боль, разбитость, лихорадка до фебрильных значений;
3. отказ от пищи и питья;
4. нарастающий тризм жевательной мускулатуры;
5. невнятная, гнусавая речь;
6. вынужденное положение головы набок, поворот всем корпусом.

Передневерхний абсцесс

1. резкое выбухание верхнего полюса миндалины вместе с нёбными дужками и мягким нёбом к средней линии;
2. язычок смещён в противоположную сторону;
3. миндалина оттеснена книзу и кзади.

Задний абсцесс

1. припухлость в области задней нёбной дужки, возможен переход на боковую стенку глотки;
2. миндалина и передняя дужка изменены незначительно;
3. отёк язычка и мягкого нёба.

Нижний абсцесс

1. при фарингоскопии лишь отёк и инфильтрация нижней части передней дужки при выраженных жалобах;
2. возможно вовлечение корня языка, отёк язычной поверхности надгортанника;
3. распространение отёка на гортань может привести к её стенозу.

Боковой абсцесс

1. встречается реже других, но протекает тяжелее всех: условия для самопроизвольного прорыва гноя в глотку наименее благоприятны;
2. отёк и инфильтрация мягких тканей шеи на стороне поражения;
3. кривошея;
4. тризм;
5. при фарингоскопии лишь умеренное выбухание всей миндалины.

2.5 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. недавно перенесённые ангины;
2. хронический тонзиллит;
3. паратонзиллиты и абсцессы в прошлом и их лечение;
4. кариес;
5. возможное попадание инородного тела (рыбная кость).

Местные жалобы

1. выраженная, как правило односторонняя боль в горле, усиливающаяся при глотании, с иррадиацией в ухо и зубы;
2. ощущение инородного тела;
3. гнусавость;
4. неприятный запах изо рта;
5. боль в шее при поворотах головы;
6. тризм;
7. слюнотечение.

Общие жалобы (неспецифичны)

1. слабость, разбитость;
2. фебрильная лихорадка;
3. головная боль.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании:

1. анамнеза;
2. физикального обследования с оценкой подчелюстной области и регионарных лимфатических узлов;
3. фарингоскопии;
4. лабораторных исследований.

3.1 Осмотр и фарингоскопия

Показания

1. подозрение на паратонзиллярный абсцесс: осмотр оториноларинголога.

Фарингоскопия показана всем детям и взрослым; выявление фарингоскопических признаков является решающим в диагностике паратонзиллярного абсцесса.

Диагностические признаки (наиболее выражены при переднем абсцессе)

1. яркая гиперемия, отёк и инфильтрация нёбных дужек, миндалин, мягкого нёба и язычка;
2. асимметрия мягкого нёба;
3. смещение миндалины;
4. ограничение открывания рта;
5. регионарный лимфаденит.

3.2 Ларингоскопия

Показания

1. подозрение на распространение воспаления на гортаноглотку: непрямая ларингоскопия или фиброларингоскопия.

3.3 КТ и УЗИ шеи

Показания

1. уточнение диагноза и локализации абсцесса;
2. оценка состояния регионарных лимфатических узлов;
3. дифференциальная диагностика воспаления паратонзиллярной клетчатки и более глубоких отделов шеи.

КТ и УЗИ шеи применяют в тяжёлых случаях, когда точный диагноз или локализацию абсцесса установить не удаётся.

3.4 Анализы крови и мочи, посев

Показания

1. все пациенты: развёрнутый общий анализ крови, С-реактивный белок (СРБ), общий анализ мочи.

Диагностические признаки

1. выраженный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и высокий СРБ: высокий риск осложнений, нужна коррекция лечения, в том числе антибактериальной терапии.

Показания

1. гнойное отделяемое после вскрытия: посев на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности;
2. мазок с миндалин на палочку дифтерии: исключение дифтерии.

Для исследования предпочтительно брать не сам гной, а смыв или мазок со стенок полости, поскольку ферменты гноя разрушают микроорганизмы. Материал доставляется в лабораторию в транспортной среде, оптимально **в течение 40 минут**.

3.5 Дифференциальная диагностика

Дифференцируют также с абсцессами подъязычной области и перикоронитом.

При сходной односторонней припухлости ротоглотки (дифтерия, скарлатина) прежде всего учитывают эпидемиологические данные.

Заболевание	Отличия от паратонзиллярного абсцесса
Дифтерия	1. слизистая бледная, с цианотичным оттенком (отёк); 2. налёты сероватые, выходят за пределы миндалин; 3. тризма нет; 4. при микробиологическом исследовании выделяют токсигенные (tox+) штаммы Corynebacterium diphtheriae.
Скарлатина	1. розеолёзная сыпь на коже; 2. чёткая граница поражённой и интактной слизистой; 3. «малиновый» язык.
Абсцесс язычной миндалины	1. нет тризма; 2. нет характерных изменений в ротоглотке.
Флегмона дна полости рта	1. боль, отёк и инфильтрация в подчелюстной области; 2. движения языка ограничены; 3. нёбные дужки и миндалины не изменены.
Опухоли миндалины: рак, лимфосаркома, лимфоэпителиома	1. медленное развитие; 2. нет лихорадки, сильной боли в горле и тризма; 3. регионарные лимфатические узлы плотные, малоболезненные, малоподвижные.

Заболевание	Отличия от паратонзиллярного абсцесса
Поверхностное расположение сонной артерии или её аневризма (редко)	1. визуально определяемая пульсация.

4. Лечение

Лечение осуществляет оториноларинголог в специализированном учреждении; основным методом лечения является хирургическая санация полости абсцесса.

Иногда при своевременном адекватном консервативном лечении воспалительный процесс в паратонзиллярном пространстве подвергается обратному развитию; возможна также инкапсуляция небольшого абсцесса.

4.1 Хирургическое лечение

Впервые возникший абсцесс: вскрытие и дренирование.

Правила (при любой технике)

1. убедиться в отсутствии пульсации в месте разреза;
2. глубже **0,5 см** продвигаться только тупым путём;
3. разрез достаточно широкий, **до 4 см**.

Местная аппликационная анестезия; место разреза по локализации:

1. передневерхний: через переднюю нёбную дужку в типичном месте или в месте наибольшего выбухания;
2. задний: через заднюю дужку, отступив 0,5 см от её края;
3. нижний: в нижней части передней дужки.

Ткани рассекают вдоль хода сосудов на глубину 0,5–1 см, далее разводят корнцангом. После вскрытия проводятся полоскания глотки растворами антисептиков.

В последующем края разреза регулярно разводятся до начала заживления полости.

Абсцесстонзиллэктомия (удаление нёбных миндалин одновременно со вскрытием) устраняет и сам очаг инфекции. Показания:

1. частые ангины в анамнезе;
2. повторный паратонзиллит или абсцесс;
3. затяжное течение;
4. неадекватное дренирование;
5. кровотечение после вскрытия;
6. прочие тонзиллогенные осложнения.

Возраст: **от 3–4 до 70 лет и старше**.

Противопоказания

1. терминальное или крайне тяжёлое состояние вследствие заболеваний внутренних органов;
2. тромбоз сосудов мозга;
3. разлитой менингит.

После операции осматривают тонзиллярную нишу; выбухание в ней свидетельствует о парафарингеальном абсцессе.

4.2 Антибактериальная терапия

1. начинают эмпирически, не дожидаясь результатов посева;
2. в этиологии абсцесса велико значение микробных ассоциаций с участием облигатных анаэробов, поэтому необходимы препараты широкого спектра, активные и в отношении анаэробов.

Курс **10–14 дней**.

1. препараты выбора: пенициллины, в том числе с ингибиторами бета-лактамаз;
2. затруднённое глотание: диспергируемые формы, суспензии, инъекции;
3. выраженный отёк тканей глотки и шеи, выраженный тризм, высокий риск генерализации: парентеральные цефалоспорины III поколения, при непереносимости клиндамицин;
4. дети: предпочтительны ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой; доза зависит от возраста и массы тела.

Препарат	Режим дозирования
Пероральные антибактериальные препараты	
Амоксициллин и клавулановая кислота внутрь	1. взрослые и дети от 12 лет или с массой тела от 40 кг: 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки; 2. дети до 12 лет: 20–40 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
#Амоксициллин с сульбактамом внутрь	1. взрослые и дети от 12 лет: 1 г 2–3 раза в сутки; 2. длительность: **до 10 дней**.
Парентеральные антибактериальные препараты	
Цефтриаксон внутримышечно или внутривенно	1. взрослые: 2 г 1 раз в сутки; 2. новорождённые до 2 недель: 20–50 мг/кг 1 раз в сутки, не более 50 мг/кг в сутки; 3. дети от 15 дней до 12 лет: 20–80 мг/кг 1 раз в сутки; 4. длительность: в таблице рекомендации указана как «в течение 4–14 дней до 10 дней».
Цефотаксим внутримышечно или внутривенно	1. взрослые: 1 г 2 раза в сутки; 2. новорождённые и дети до 12 лет: 50–100 мг/кг в сутки с интервалом 6–12 часов; 3. недоношенные: не более 50 мг/кг в сутки; 4. длительность: **до 10 дней**.
Клиндамицин	1. взрослые: 300 мг 2 раза в сутки, при тяжёлом течении до 1,2–4,8 г в сутки в 2–4 приёма; 2. дети при непереносимости цефалоспоринов III поколения: #20–40 мг/кг в сутки в 3–4 приёма.

4.3 Дополнительная терапия

При выраженных воспалительных проявлениях используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в стандартных дозах.

Всем пациентам рекомендованы антигистаминные препараты системного действия.

Рекомендацией предусмотрено также применение средств, повышающих естественную резистентность организма (препараты кальция, витамины С и А); при этом следует избегать полипрагмазии.

При выраженной интоксикации необходима инфузионная дезинтоксикационная терапия.

Всем пациентам дополнительно местные противовоспалительные, обезболивающие и антисептические средства; системную антибактериальную терапию они не заменяют.

Лекарственные формы местных средств

1. полоскания;
2. инсуффляции;
3. ингаляции;
4. таблетки для рассасывания.

При назначении местных антисептиков соблюдают разрешённую кратность приёма и возрастные ограничения (некоторые из них токсичны), учитывают возможность аллергических реакций и индивидуальной непереносимости.

После хирургического лечения, не ранее чем через 3 недели после купирования острого воспаления, показана консультация физиотерапевта.

4.4 Послеоперационное ведение

После вскрытия абсцесса: двусторонняя тонзиллэктомия в плановом порядке **через 3 месяца**.

После тонзиллэктомии ограничение физической нагрузки **в течение месяца**.

---

5. Профилактика. Показания к госпитализации. Осложнения

1. при диспансеризации выявляют факторы риска: хронический тонзиллит, рецидивирующие ангины;
2. закаливание;
3. своевременное лечение заболеваний зубов и дёсен.

Лечение в хирургическом стационаре.

Показания к госпитализации

1. вскрытие абсцесса;
2. удаление нёбных миндалин со вскрытием абсцесса.

Улучшение состояния после вскрытия абсцесса наблюдается уже **через 12–24 часа**.

Критерии выписки

1. устойчивое купирование проявлений болезни и отсутствие угрозы жизни и здоровью пациента;
2. после удаления нёбных миндалин со вскрытием абсцесса при неосложнённом течении: **на 5–7-е сутки** после операции.

Осложнения при отсутствии или неадекватности лечения

1. флегмона шеи;
2. медиастинит;
3. тонзиллогенный сепсис;
4. инфекционно-токсический шок.

Риск выше при иммунодефиците: врождённом, на фоне иммуносупрессоров и цитостатиков, при ВИЧ-инфекции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Паратонзиллярный абсцесс»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	664_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для цефтриаксона в таблице 1 указано «в течение 4-14 дней до 10 дней», что содержит противоречие в сроках; на странице формулировка приведена дословно.